

压力性尿失禁 — 女性

WARWIKI

患者须知 · 咳嗽、大笑、提重物或运动时漏尿

压力性尿失禁（SUI）是指腹压骤然升高时漏尿，例如咳嗽、打喷嚏、大笑、提重物或运动。女性发生这种情况是因为尿道下方的支撑组织减弱，常见于分娩后或绝经后。该病非常普遍，也非常可治，从简单的锻炼到效果显著的小手术均可选择。

关于这种疾病

尿道（尿液流出的管道）在正常情况下咳嗽或用力时会保持关闭，依靠盆底支撑和周围组织维持。当该支撑减弱时，腹压骤然升高就会将尿液挤出。其典型表现是**活动时漏尿**，而非突然尿急（那是膀胱过度活动症；两者同时存在称为**混合性尿失禁**）。

病因

- **妊娠和分娩**（主要原因）
- **绝经和衰老**
- 慢性咳嗽、便秘或长期提重物
- 体重超标，以及既往盆腔手术史

名词解释

压力性尿失禁

腹压升高时漏尿，如咳嗽、提重物、运动。

尿道

将尿液排出体外的管道。

盆底

支撑膀胱和尿道的肌肉群。

凯格尔运动

通过收缩盆底肌来增强支撑力的锻炼。

混合性尿失禁

同时存在压力性漏尿和急迫性漏尿。

子宫托／支撑器

放置于阴道内的小型支撑装置，可减少漏尿。

尿道填充剂注射

门诊注射，帮助尿道更好地闭合。

尿道中段吊带

手术中在尿道下方放置的小型网片支撑物。

我需要手术吗？ 不一定。许多女性通过盆底肌锻炼和简单调整即可改善症状，部分患者使用支撑装置即可。手术（如吊带手术）效果很好，适合希望长期解决问题的患者——但这是您的选择，可以先从简单的方法开始。

如何诊断

- 问诊了解漏尿情况，并进行体格检查（有时做咳嗽试验）
- **尿液检查**排除感染，并评估膀胱排空情况
- 术前有时需要膀胱功能检测（尿动力学检查）

如何治疗（分步骤）

- 1 **盆底肌锻炼**（凯格尔运动）及物理治疗，同时减重、治疗咳嗽或便秘。
- 2 **支撑装置**——阴道子宫托或非处方支撑器。
- 3 **填充剂注射**——门诊快速注射，帮助尿道闭合。
- 4 **手术**——**尿道中段吊带**（或自体筋膜吊带）实现持久修复，每种方案均有专属说明。

日常管理

- 学会在**咳嗽、打喷嚏或提重物前先收缩盆底肌**（"预收缩技巧"）。
- 每天坚持盆底肌锻炼——通常需要6至12周才能见效。
- 积极治疗便秘和慢性咳嗽，减少腹压升高。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 排尿时烧灼感、尿急或**血尿**（可能感染）
- 同时伴有**强烈尿急**的漏尿——治疗方案可能不同
- 感觉膀胱排空不完全

需要记住的三件事

1. 女性压力性尿失禁是因尿道下方支撑减弱导致腹压升高时漏尿，十分常见且可有效治疗。
2. 治疗方案从盆底肌锻炼、支撑装置，到门诊填充剂注射，再到吊带手术持久修复，层层递进。
3. 锻炼需数周见效；咳嗽或提重物前先收缩盆底。手术是选择，而非必须。